

Наиболее защищенными в настоящее время от туберкулеза в силу естественной резистентности, а также благодаря профилактическим мероприятиям оказались: {

~ дети и подростки

= дети и лица среднего возраста (40-59 лет)

~ дети и молодые люди (20-39 лет)

~ дети и пожилые люди (60 лет и старше)

}

Заболевание туберкулезом в настоящее время чаще выявляются: {

~ у детей

~ у подростков

= у лиц молодого возраста (до 40 лет)

~ у лиц среднего возраста (40-59 лет)

~ у пожилых людей (60 лет и старше)

}

Очаг туберкулезной инфекции со скудным бактериовыделением (обнаружение БК только методом посева) не имеет существенного значения для инфицирования лиц ближайшего окружения: {

= при высокой пораженности туберкулезом населения в данном районе

~ при умеренной пораженности населения туберкулезом

~ при малой пораженности населения туберкулезом в данном районе

~ при низкой пораженности туберкулезом в данном районе

}

К высокой заболеваемости населения туберкулезом можно отнести выявление: {

=100 заболевших на 100 000 населения

~30-50 заболевших на 100 000 населения

~20 заболевших на 100 000 населения

~ 10 заболевших на 100 000 населения

}

К умеренной заболеваемости населения туберкулезом следует отнести

показатель при выявлении {

~100 заболевших на 100 000 населения

=30-50 заболевших на 100 000 населения

~20 заболевших на 100 000 населения

~5 заболевших на 100 000 населения

}

К низкому показателю болезненности населения туберкулезом можно

отнести выявление: {

~100 больных туберкулезом, находящихся на учете, на 100 000 населения

~30 больных туберкулезом, находящихся на учете, на 100 000 населения

~50 больных туберкулезом, находящихся на учете, на 100 000 населения

=20 больных туберкулезом, находящихся на учете, на 100 000 населения

}

К низкому показателю болезненности населения туберкулезом можно

отнести : {

~500 больных туберкулезом, находящихся на учете, на 100 000 населения

~200 больных туберкулезом, находящихся на учете, на 100 000 населения

=100 больных туберкулезом, находящихся на учете, на 100 000 населения

~700 больных туберкулезом, находящихся на учете, на 100 000 населения
}

Ежегодный прирост инфицирования населения туберкулезом, оцененный по динамике кожной туберкулиновой пробы, свидетельствующий о высокой пораженности населения данного города (района, области) туберкулезом, начинается{

~с 20% и более

~с 10% и более

=с 1% и более

~с 0.1% и более

}

Один нелеченный бациллярный больной туберкулезом за год заражает (инфицирует): {

~около 20 человек

=около 10 человек

~около 3-5 человек

~около 1 человека

}

Наибольшую опасность для окружающих представляет: {

= больной с инфильтративным туберкулезом без распада, БК в мокроте определяется методом бактериоскопии

~ больной с инфильтративным туберкулезом в фазе распада, БК в мокроте определяется методом посева

~ больной с фиброзно-кавернозным туберкулезом, БК в мокроте выявляется только методом посева

~ больной с очаговым туберкулезом, БК в мокроте выявляется только методом посева

}

У человека, перенесшего ранее туберкулез, и имеющего остаточные рентгенологические изменения (архив), риск заболеть туберкулезом по сравнению с прочим населением выше{

~в 2 раза

~в 3 раза

=в 5-10 раз

~в 20 раз

}

Больного с симптомами бронхита, у которого в мокроте повторно обнаружены БК, но на рентгенограмме и томограмме легких и органов средостения изменения не обнаружены{

~необходимо взять на учет как бациллярного больного и назначить ему лечение в амбулаторных условиях

~необходимо взять на учет по 0-й группе и наблюдать

=необходимо госпитализировать в клинику для бронхологического обследования и лечения

~необходимо взять на учет по 3-й группе и наблюдать

}

Среди инфекционных заболеваний туберкулез, как причина, приведшая к летальному исходу, занимает{

=1-е место

~5-е место

~6-е место

~8-е место

}

"Случай туберкулеза", по критериям ВОЗ –это {

~хроническое заболевание,

сопровожающееся рецидивирующим кашлем с выделением мокроты и изменениями на рентгенограмме, специфичными для него

~заболевание, сопровождающееся изменениями на рентгенограмме в области верхних отделов легких, а также в прикорневых лимфоузлах

~заболевание, подтвержденное специфическими изменениями на рентгенограмме или морфологическими изменениями в виде гигантоклеточной гранулемы с казеозным некрозом

=заболевание, подтвержденное обнаружением микобактерий туберкулеза, выделенных из очага поражения (с мокротой, мочой и т.д.) или полученных из тканей путем биопсии

}

Основными методами выявления туберкулеза у детей является {

=массовая туберкулинодиагностика

~флюорография

~обследование на туберкулез групп риска

~обследование на туберкулез лиц обратившихся к фтизиатру

}

Основной метод выявления туберкулеза у подростков –это {

~туберкулинодиагностика

~обследование по контакту

~флюорография

=обследование по обращаемости

}

Массовую туберкулинодиагностику среди детей следует проводить {

~ 1 раз в 6 месяцев

=1 раз в 1 год

~4 раза в 1 год

~1 раз в два года

}

Флюорографическое обследование подростков должно проводиться {

~1 раз в 1 год

~1 раз в 2 года

~2 раза в 1 год

=в зависимости от эпидситуации и профориентации подростка

}

Систематическое флюорографическое обследование населения на туберкулез проводится

~с 10-летнего возраста

~с 12-летнего возраста

~с 15-летнего возраста

~с 18-летнего возраста

=выбор возраста определяется эпидемической ситуацией

}

Выборочное обследование на туберкулез часто болеющих детей и подростков проводится: {

~врачом-терапевтом

=фтизиатром

~врачами-специалистами

~врачом-пульмонологом

}

Проведение массовой туберкулинодиагностики осуществляется {

=общей педиатрической сетью

~противотуберкулезным диспансером

~противотуберкулезным стационаром

~санэпидемиологической службой

}

Основное показание к проведению ревакцинации БЦЖ - это

~положительная реакция Манту с 2 ТЕ

=отрицательная реакция Манту с 2 ТЕ

~сомнительная реакция Манту с 2 ТЕ

~контакт с больным туберкулезом

}

Отличие вакцины БЦЖ от БЦЖ-М

~в дозе препарата {

=в количестве живых микробных тел

~в приготовлении вакцины

~ в способе введения

}

Вакцина БЦЖ-М применяется {

=у недоношенных детей

~у ослабленных детей

~у детей с иммунодефицитом

~у инфицированных детей

}

Длительность хранения открытой вакцины БЦЖ должна быть не более {

=3 часов

~ 5 часов

~ 8 часов

~одних суток

}

После вакцинации БЦЖ при наличии в семье больного туберкулезом ребенок изолируется {

~ на 1 месяц

= на 2 месяца

~ на 5 месяцев

~ на 1 год

}

Послевакцинальный иммунитет формируется в течении {

~2 лет

=1 года

~ 5 лет

~ 6 лет

}

Заболеваемость туберкулезом –это {

~число больных туберкулезом в пересчете на 1000 жителей

~число больных туберкулезом в пересчете на 10 000 жителей

~процент больных, исчисленный к населению данной местности

~число больных туберкулезом, выявленных в данном году

=число вновь выявленных больных туберкулезом в пересчете на 100 000 населения

}

Показатель болезненности при туберкулезе - это {

= число больных туберкулезом, стоящих на учете на конец года, в пересчете на 100 000 жителей

~ число больных активным туберкулезом на конец года

~ удельный вес больных туберкулезом среди всех больных на данной территории

~ число больных туберкулезом в пересчете на 1000 жителей

}

Показатель абациллирования контингентов —это {

= число абациллированных и снятых с учета в текущем году больных, умноженное на 100 и деленное на число больных с БК=в учетном году

~ процент больных с БК(-) ко всему контингенту больных

~ число больных с БК(-) на 100 больных с БК(=)

~ число больных, снятых с бациллярного учета

}

Клиническое излечение туберкулеза определяется по формуле {

~ число больных, переведенных в неактивные группы)* 100/(число больных активным туберкулезом (I=II гр.)

~ (число больных, снятых с учета)*100/(число больных в контингенте)

((число больных III==II гр. Диспансерного учета)*100/(общее число больных туберкулезом)

= (число больных, переведенных в III группу)/(1000 больных туберкулезом)

~ число больных снятых с учета в течении года

}

Временная утрата трудоспособности —это {

~утрата трудоспособности на 2 месяца

~утрата трудоспособности на 4 месяца

~утрата трудоспособности на 6 месяцев

~утрата трудоспособности на 1 год

=когда нарушение функции организма в результате болезни носят временный (обратимый) характер, и человек не теряет свою профессию и свою квалификацию

}

Стойкая утрата трудоспособности –это {

~утрата трудоспособности на 6 месяцев

~утрата трудоспособности на 1 год

~утрата трудоспособности на 2 года

=когда нарушение функции организма в результате болезни носят стойкий, необратимый или частично обратимый характер, при этом человек прекращает работу или переходит на облегченные условия труда

}

Факт временной утраты трудоспособности устанавливает {

=лечащий врач

~главный врач

~ ВТЭК

~ заведующий отделением

}

Максимальная длительность пребывания на больничном листе впервые

выявленного больного туберкулезом включает {

~период стационарного лечения

~4 месяца в году

=10 месяцев в календарном году

~5 месяцев с перерывами

}

Больным с хроническими формами туберкулеза лист нетрудоспособности
выдается{

~на период обострения туберкулезного процесса

~на период вплоть до прекращения

бактериовыделения

~до 10 месяцев

=на 4 месяца непрерывно и не более 5 месяцев в течение года с
последующим направлением во ВТЭК

}

Инвалидам не по туберкулезу, но работающим при наступлении временной
нетрудоспособности вследствие туберкулеза, больничный лист{

~не выдается

~выдается на 4 месяца в году

~выдается на период стационарного лечения

=не более 10 месяцев подряд

}

Лист нетрудоспособности работающим инвалидам по туберкулезу при
обострении этого заболевания{

~выдается на 2 месяца

~не выдается

=выдается не более 5 месяцев в календарном году

~выдается до 10 месяцев

}

Больничный лист работающим пенсионерам при их заболевании
туберкулезом{

~не выдается

~выдается на весь период заболевания

~выдается до 4 месяцев подряд и не более 3 месяцев в календарном году

=выдается на общих основаниях до 10 месяцев в году

}

Возбудители туберкулеза относятся к виду{

=бактерий

~грибов

~простейших

~вирусов

}

Лица с остаточными изменениями ранее перенесенного туберкулеза{

~ заболевают туберкулезом реже населения, не имеющего на рентгенограмме остаточных туберкулезных изменений

~ одинаково часто заболевают, как и население, не имеющее остаточных туберкулезных изменений

=в несколько раз чаще заболевают

туберкулезом по сравнению с лицами, не имеющими на рентгенограмме остаточных туберкулезных изменений

~ не заболеют туберкулезом никогда

}

Лица, инфицированные туберкулезом, в последующем заболевают этой инфекцией{

~в 0.1% случаев

=в 4-5% случаев

~в 10-15% случаев

~в 20% случаев

}

"Первичный туберкулез" - это

~туберкулез внутригрудных лимфатических узлов

~первичный туберкулезный комплекс

=заболевание, возникшее вскоре после инфицирования

~ туберкулезная интоксикация }

Легочная локализация первичного туберкулеза –это{

~очаг Гона

~легочный туберкулез, протекающий с поражением внутригрудных лимфатических узлов

=легочный туберкулез, возникший вскоре после инфицирования микобактериями туберкулеза

~туберкулома

}

Современная отечественная классификация туберкулеза построена{

~на клиническом принципе

~на патогенетическом принципе

~на морфологическом принципе

=на клинико-рентгенологическом принципе

~на клинико-иммунологическом принципе

}

Бронхи 1-2-го порядка от других бронхиальных ветвей отличаются{

~наличием фиброзно-хрящевого слоя

=внелегочной их локализацией

~отсутствием фиброзно-хрящевого слоя и заменой его мышечным

~ внутрилегочной локализацией

}

Бронхи 1-6-го (9-го) порядка от последующих их генераций отличаются{

=наличием фиброзно-хрящевого слоя

~тесной анатомо-функциональной связью спаренхимой легкого

~внелегочной локализацией

~отсутствием фиброзно-хрящевого слоя и заменой его мышечным

}

Инфекционный воспалительный процесс в стенке мембранного бронха легко переходит на паренхиму легкого{

~из-за наличия в нем фиброзно-хрящевого слоя и перибронхиальной ткани

~из-за внелегочной его локализации

=из-за тесной анатомо-функциональной связи бронха с паренхимой легкого

~из-за его формы

}

Многоклеточные серозно-слизистые железы имеются в стенке бронхов{

=1-3-го порядка

~1-6-го (9-го) порядка

~7-го (10-го) порядка

~ более мелких

}

Одноклеточные слизистые железы (бокаловидные клетки) отсутствуют в стенке бронхов{

~ 1-3-го порядка

~1-6-го (9-го) порядка

=7-го (10-го) порядка

~ более мелких

}

За сутки слизистой оболочкой продуцируется и выводится в ротоглотку{

~ до 50 мл слизи

=150-200 мл слизи

~1200-300 мл слизи

~ 1500 мл слизи

}

Слизь выводится из дыхательных путей в ротоглотку с помощью{

~кашлевого толчка

~дыхательных движений воздуха

~перистальтики бронха

=движение ресничек мерцательного эпителия

}

Перечисленные ниже факторы обеспечивают хорошую функцию мукоцилиарного аппарата, кроме{

~числа функционирующих клеток реснитчатого эпителия

=длины и числа ресничек в клетке

~реологических свойств слизи (вязкость, прилипание)

~функциональной активности клеток реснитчатого эпителия

}

Синуситы, бронхиты и бронхоэктазы возникают в связи с функциональной недостаточностью клеток мерцательного эпителия воздухоносных путей при синдроме{

~Мак-Леода

=Картагенера - Зиверта

~Вильямса –Кембелла

~ Брудзинского

}

Перечисленные ниже биологически активные вещества слизи дыхательных путей обеспечивают противовирусную, антимикробную и антипаразитарную их защиту, кроме{

~интерферонов

~лизоцима

~лактоферрина

~иммуноглобулинов

=простагландинов

}

Защита альвеолы от повреждающих ее агентов осуществляется{

~удалением их с фазами дыхательных движений

~удалением ресничками мерцательного эпителия

~фагоцитозом нейтрофилами

=фагоцитозом альвеолярными макрофагами

}

Функцией неинкапсулированных скоплений лимфоидной ткани легких является{

~фагоцитоз инородных тел

=синтез иммуноглобулинов

~формирование клеточных факторов иммунного ответа

~ все перечисленное

}

Плевральные листки выполняют все следующие функции, кроме{

~барьера

~поддержания капиллярного слоя жидкости в плевральной щели

~участия в эластической тяге легкого

~обеспечения равномерной вентиляции паренхимы легкого

=обеспечения равномерного кровотока в системе бронхиальных артерий

}

Висцеральный листок плевры выполняет все следующие функции, кроме{

~участия в эластической тяге легкого

~резорбции воды и кристаллоидов

=резорбции белковых продуктов

~барьера

}

Основными звеньями иммунитета являются все перечисленные, кроме{

~клеточного звена

~гуморального звена

=нейроэндокринного звена

~макрофагально-фагоцитарной системы

}

Противотуберкулезный иммунитет

определяется следующими перечисленными факторами, кроме{

~фагоцитоза

~повышенной чувствительности замедленного типа (ПЧЗТ)

~антителообразования

~иммунологической памяти

=особенностей микобактерии туберкулеза

}

Основными видами нарушения функции внешнего дыхания являются все перечисленные, кроме{

~вентиляционных

~диффузных

~перфузионных

=нарушения транспорта O_2 и CO_2

}

Проба Тиффно в норме составляет{

~50% ЖЕЛ

~60% ЖЕЛ

~70% ЖЕЛ

=80% ЖЕЛ

}

Насыщение артериальной крови O₂ в норме составляет {

~75%

~80%

=95%

~70%

}

Ежегодный прирост инфицирования населения туберкулезом, оцененный по динамике кожной туберкулиновой пробы, свидетельствующий о высокой пораженности населения данного города (района, области) туберкулезом, начинается {

~с 20% и более

~с 10% и более

=с 1% и более

~с 0.1% и более

}

Один нелеченный бациллярный больной туберкулезом за год заражает (инфицирует): {

~около 20 человек

=около 10 человек

~около 3-5 человек

~около 1 человека

}

Наибольшую опасность для окружающих представляет: {

= больной с инфильтративным туберкулезом без распада, БК в мокроте определяется методом бактериоскопии

~ больной с инфильтративным туберкулезом в фазе распада, БК в мокроте определяется методом посева

~ больной с фиброзно-кавернозным туберкулезом, БК в мокроте выявляется только методом посева

~ больной с очаговым туберкулезом, БК в мокроте выявляется только методом посева

}

У человека, перенесшего ранее туберкулез, и имеющего остаточные рентгенологические изменения (архив), риск заболеть туберкулезом по сравнению с прочим населением выше {

~в 2 раза

~в 3 раза

=в 5-10 раз

~в 20 раз

}

Больного с симптомами бронхита, у которого в мокроте повторно обнаружены БК, но на рентгенограмме и томограмме легких и органов средостения изменения не обнаружены {

~необходимо взять на учет как бациллярного больного и назначить ему лечение в амбулаторных условиях

~необходимо взять на учет по 0-й группе и наблюдать

=необходимо госпитализировать в клинику для бронхологического обследования и лечения

~необходимо взять на учет по 3-й группе и наблюдать

}

Среди инфекционных заболеваний туберкулез, как причина, приведшая к летальному исходу, занимает{

=1-е место

~5-е место

~6-е место

~8-е место

}

"Случай туберкулеза", по критериям ВОЗ –это{

~хроническое заболевание,

сопровождающееся рецидивирующими кашлем с выделением мокроты и изменениями на рентгенограмме, специфичными для него

~заболевание, сопровождающееся изменениями на рентгенограмме в области верхних отделов легких, а также в прикорневых лимфоузлах

~заболевание, подтвержденное специфическими изменениями на рентгенограмме или морфологическими изменениями в виде гигантоклеточной гранулемы с казеозным некрозом

=заболевание, подтвержденное обнаружением микобактерий туберкулеза, выделенных из очага поражения (с мокротой, мочой и т.д.) или полученных из тканей путем биопсии

}

Основными методами выявления туберкулеза у детей является{

=массовая туберкулинодиагностика

~флюорография

~обследование на туберкулез групп риска

~обследование на туберкулез лиц обратившихся к фтизиатру

}

Основной метод выявления туберкулеза у подростков –это{

~туберкулинодиагностика

~обследование по контакту

~флюорография

=обследование по обращаемости

}

Массовую туберкулинодиагностику среди детей следует проводить {

~ 1 раз в 6 месяцев

=1 раз в 1 год

~4 раза в 1 год

~1 раз в два года

}

Флюорографическое обследование подростков должно проводиться {

~1 раз в 1 год

~1 раз в 2 года

~2 раза в 1 год

=в зависимости от эпидситуации и профориентации подростка

}

Систематическое флюорографическое обследование населения на туберкулез
проводится

~с 10-летнего возраста

~с 12-летнего возраста

~с 15-летнего возраста

~с 18-летнего возраста

=выбор возраста определяется эпидемической ситуацией

}

Выборочное обследование на туберкулез часто болеющих детей и подростков проводится: {
~врачом-терапевтом
=фтизиатром
~врачами-специалистами
~врачом-пульмонологом
}

Проведение массовой туберкулинодиагностики осуществляется {
=общей педиатрической сетью
~противотуберкулезным диспансером
~противотуберкулезным стационаром
~санэпидемиологической службой
}

Основное показание к проведению ревакцинации БЦЖ - это
~положительная реакция Манту с 2 ТЕ
=отрицательная реакция Манту с 2 ТЕ
~сомнительная реакция Манту с 2 ТЕ
~контакт с больным туберкулезом
}

Отличие вакцины БЦЖ от БЦЖ-М
~в дозе препарата {
=в количестве живых микробных тел
~в приготовлении вакцины
~ в способе введения
}

Вакцина БЦЖ-М применяется {

=у недоношенных детей

~у ослабленных детей

~у детей с иммунодефицитом

~у инфицированных детей

}

Длительность хранения открытой вакцины БЦЖ должна быть не более{

=3 часов

~ 5 часов

~ 8 часов

~одних суток

}

После вакцинации БЦЖ при наличии в семье больного туберкулезом ребенок изолируется{

~ на 1 месяц

= на 2 месяца

~ на 5 месяцев

~ на 1 год

}

Послевакцинальный иммунитет формируется в течении {

~2 лет

=1 года

~ 5 лет

~ 6 лет

}

Заболеваемость туберкулезом –это{

~число больных туберкулезом в пересчете на 1000 жителей

~число больных туберкулезом в пересчете на 10 000 жителей

~процент больных, исчисленный к населению данной местности

~число больных туберкулезом, выявленных в данном году

=число вновь выявленных больных туберкулезом в пересчете на 100 000 населения

}

Показатель болезненности при туберкулезе - это {

= число больных туберкулезом, стоящих на учете на конец года, в пересчете на 100 000 жителей

~ число больных активным туберкулезом на конец года

~ удельный вес больных туберкулезом среди всех больных на данной территории

~ число больных туберкулезом в пересчете на 1000 жителей

}

Показатель абациллирования контингентов —это {

= число абациллированных и снятых с учета в текущем году больных, умноженное на 100 и деленное на число больных с БК=в учетном году

~ процент больных с БК(-) ко всему контингенту больных

~ число больных с БК(-) на 100 больных с БК(=)

~ число больных, снятых с бациллярного учета

}

Клиническое излечение туберкулеза определяется по формуле {

~ число больных, переведенных в неактивные группы)* 100/(число больных активным туберкулезом (I=II гр.)

~ (число больных, снятых с учета)*100/(число больных в контингенте)

((число больных III==II гр. Диспансерного учета)*100/(общее число больных

туберкулезом)

= (число больных, переведенных в III группу)/(1000 больных туберкулезом)

~ число больных снятых с учета в течении года

}

Временная утрата трудоспособности –это {

~утрата трудоспособности на 2 месяца

~утрата трудоспособности на 4 месяца

~утрата трудоспособности на 6 месяцев

~утрата трудоспособности на 1 год

=когда нарушение функции организма в результате болезни носят временный (обратимый) характер, и человек не теряет свою профессию и свою квалификацию

}

Стойкая утрата трудоспособности –это {

~утрата трудоспособности на 6 месяцев

~утрата трудоспособности на 1 год

~утрата трудоспособности на 2 года

=когда нарушение функции организма в результате болезни носят стойкий, необратимый или частично обратимый характер, при этом человек прекращает работу или переходит на облегченные условия труда

}

Факт временной утраты трудоспособности устанавливает {

=лечащий врач

~главный врач

~ ВТЭК

~ заведующий отделением

}

Максимальная длительность пребывания на больничном листе впервые выявленного больного туберкулезом включает{

~период стационарного лечения

~4 месяца в году

=10 месяцев в календарном году

~5 месяцев с перерывами

}

Больным с хроническими формами туберкулеза лист нетрудоспособности выдается{

~на период обострения туберкулезного процесса

~на период вплоть до прекращения

бактериовыделения

~до 10 месяцев

=на 4 месяца непрерывно и не более 5 месяцев в течение года с последующим направлением во ВТЭК

}

Инвалидам не по туберкулезу, но работающим при наступлении временной нетрудоспособности вследствие туберкулеза, больничный лист{

~не выдается

~выдается на 4 месяца в году

~выдается на период стационарного лечения

=не более 10 месяцев подряд

}

Лист нетрудоспособности работающим инвалидам по туберкулезу при обострении этого заболевания{

~выдается на 2 месяца

~не выдается

=выдается не более 5 месяцев в календарном году

~выдается до 10 месяцев

}

Больничный лист работающим пенсионерам при их заболевании
туберкулезом{

~не выдается

~выдается на весь период заболевания

~выдается до 4 месяцев подряд и не более 3 месяцев в календарном году

=выдается на общих основаниях до 10 месяцев в году

}

100

ТЗ с выбором нескольких правильных ответов

Для проведения противотуберкулезной вакцинации диспансер осуществляет{

~%25% подготовку врачей и медицинских сестер по вакцинации

~%25% методическое руководство и инструктирование

в~%25% вакцинацию и ревакцинацию детей и подростков из очагов
туберкулезной инфекции

~%25% изоляцию бактериовыделителей на период формирования
поствакцинального иммунитета

~%-100% отбор лиц на ревакцинацию

}

Задачами санитарно-эпидемиологических станций являются {

~%25% организация профосмотров на туберкулез

~%25% участие в организации вакцинации и ревакцинации против
туберкулеза

~%25% регистрация и учет бациллярных больных и работа в очаге

~%25% контроль за декретированными группами по их обследованию на туберкулез

~%-100% лечение больных туберкулезом

}

Основными эпидемиологическими показателями, используемыми фтизиатром в своей работе, являются {

~%25% заболеваемость туберкулезом

~%25% инфицированность и риск инфицирования населения микобактериями туберкулеза

~%25% болезненность населения туберкулезом

~%25% смертность от туберкулеза

~%-100% переносимость противотуберкулезных препаратов

}

Об инфицировании населения туберкулезом можно судить по перечисленным ниже критериям {

~%33.33333% обнаружение при секционном исследовании следов перенесенной ранее туберкулезной инфекции

~%33.33333% обнаружение на флюорограмме признаков перенесенного ранее туберкулеза

~%33.33333% положительная кожная проба с туберкулином

~%-100% обнаружение БК в мокроте

}

К основным группам детей, подверженных риску заразиться туберкулезом, относятся: {

~%25% невакцинированных БЦЖ

~%25% недоношенных, часто и длительно болеющих детей

~%25% живущих в очагах туберкулезной инфекции

~%25% не имеющих послевакцинального знака

~%-100% перенесших туберкулез

}

Противотуберкулезными мероприятиями, которые осуществляет общая педиатрическая сеть: {

~%33.33333% массовой туберкулинодиагностики

~%33.33333% вакцинации БЦЖ и ревакцинации БЦЖ

~%33.33333% раннего выявления туберкулеза

~%-100% дообследования детей из группы риска

}

О распространенности туберкулеза свидетельствуют такие показатели как: {

~%25% заболеваемость

~%25% болезненность

~%25% смертность

~%25% инфицированность

~%-100% индивидуальность

}

При анализе эффективности осмотров на туберкулез важны все перечисленные показатели: {

~%25% процента охвата населения осмотрами на туберкулез

~%25% частоты выявления больных активным туберкулезом

~%25% структуры выявленного контингента больных

~%25% удельного веса несвоевременного выявленных больных

~%-100% выполнения плана обследования

}

Положительными сдвигами в структуре заболеваемости туберкулезом следует считать: {

~%33.33333% уменьшения удельного веса больных с БК- и деструкцией

~%33.33333% отсутствия запущенных форм туберкулеза

~%33.33333% снижения показателя инфицированности

~%-100% повышения удельного веса больных с очаговым туберкулезом

}

Бактериовыделитель – это {

~%33.33333% больной активным туберкулезом, у которого микобактерии туберкулеза были обнаружены хотя бы один раз любым методом

~%33.33333% больной, выделявший микобактерии туберкулеза не менее 2 раз

~%33.33333% больной туберкулезом, выделяющий микобактерии всеми лабораторными методами исследования

~%-100% больной с активной формой туберкулеза

}

Увеличение показателей ранних рецидивов свидетельствует: {

~%33.33333% недостаточного лечения

~%33.33333% преждевременного перевода больных туберкулезом в III группу диспансерного наблюдения

~%33.33333% дефектов в наблюдении за больными туберкулезом в I и II группах диспансерного учета

~%-100% характеристик макро- и микроорганизма

}

11 тестов